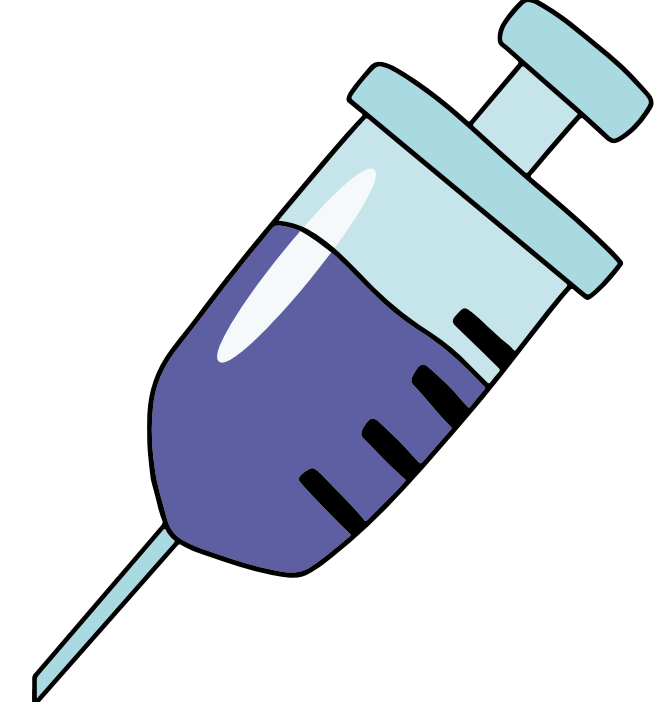
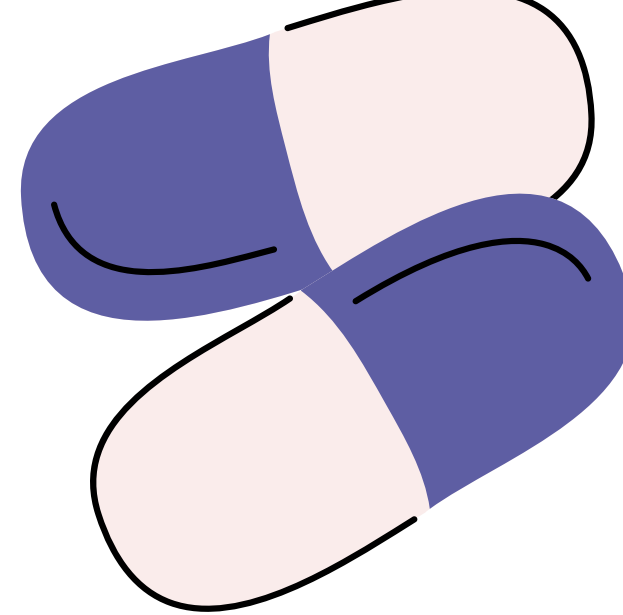
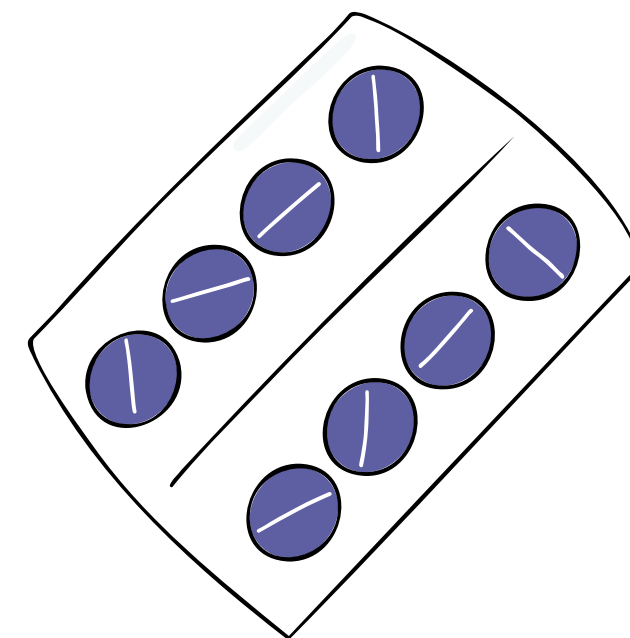
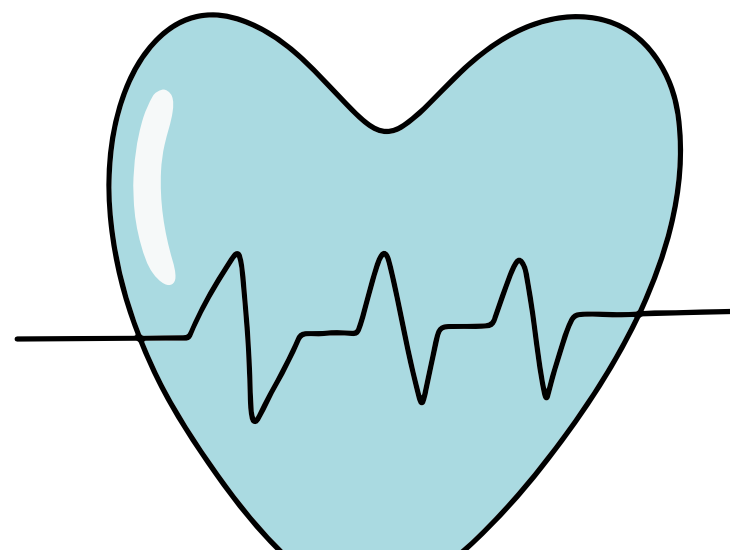




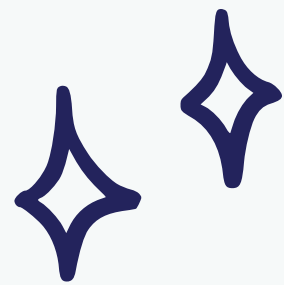
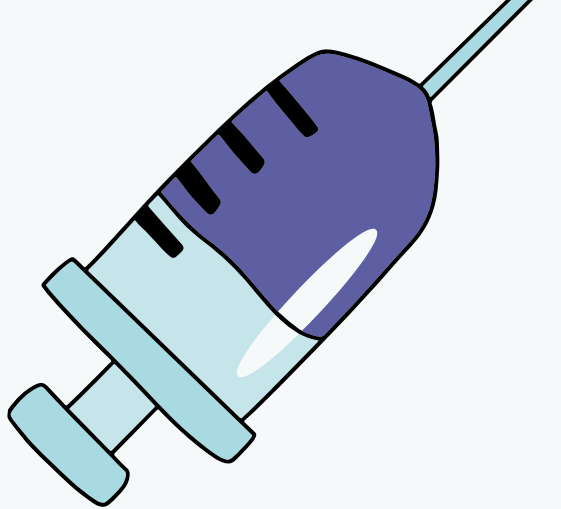
**PROTOSCOLOS DE ERROR EN LA
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
EN CHILE**



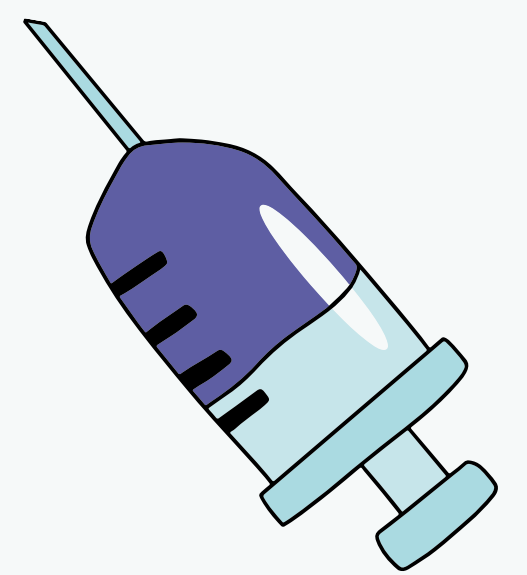
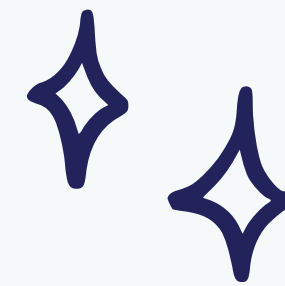
INTRODUCCION

LA SEGURIDAD DEL PACIENTE ES UNA PRIORIDAD FUNDAMENTAL EN LA ATENCIÓN MÉDICA EN CHILE. UNO DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS EN ESTE SENTIDO ES LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, DONDE LOS ERRORES PUEDEN TENER CONSECUENCIAS GRAVES PARA LA SALUD DE LOS PACIENTES. CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS AL ERROR DE MEDICACIÓN, SE ESTABLECE ESTE PROTOCOLO QUE ESTANDARIZA LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DE MEDICACIÓN, DESDE LA PRESCRIPCIÓN HASTA EL MONITOREO. ESTE PROTOCOLO ES APLICABLE A TODO EL PERSONAL DE SALUD INVOLUCRADO EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CHILENOS, Y BUSCA ASEGURAR UNA ATENCIÓN SEGURA Y DE ALTA CALIDAD PARA LOS PACIENTES





DEFINICION



PRIORIDAD EN LOS SISTEMAS DE SALUD:

LA SEGURIDAD DEL PACIENTE SE HA CONVERTIDO EN UNA PRIORIDAD GLOBAL, IMPULSADA POR ESTUDIOS QUE MUESTRAN QUE LA ATENCIÓN MÉDICA PUEDE SER UNA FUENTE SIGNIFICATIVA DE DAÑO.

IMPACTO DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN

SON UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DAÑO PREVENIBLE.

CAUSAN MÁS MUERTES QUE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, CÁNCER DE MAMA O SIDA, SEGÚN ESTUDIOS.

EL INFORME "ERRAR ES HUMANO" (1999) DEL INSTITUTO DE MEDICINA ESTIMÓ ENTRE 44,000 Y 98,000 MUERTES ANUALES POR EM PREVENIBLES EN EE. UU.

CONSECUENCIAS ADICIONALES DE LOS EM:

ECONÓMICAS: COSTOS ELEVADOS PARA LOS SISTEMAS DE SALUD.

PSICOLÓGICAS Y SOCIALES: PÉRDIDA DE CONFIANZA EN EL SISTEMA SANITARIO.

SATISFACCIÓN: REDUCCIÓN EN LA SATISFACCIÓN DE PACIENTES Y PROFESIONALES.

RIESGO DUAL DE LOS MEDICAMENTOS:

RIESGO INTRÍNSECO: REACCIONES ADVERSAS INCLUSO CON USO CORRECTO.

RIESGO POR ERRORES: DAÑOS CAUSADOS POR FALLOS EN EL PROCESO DE USO DE MEDICAMENTOS.

SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS:

SE DESTACAN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESO DONDE PUEDEN OCURRIR ERRORES:

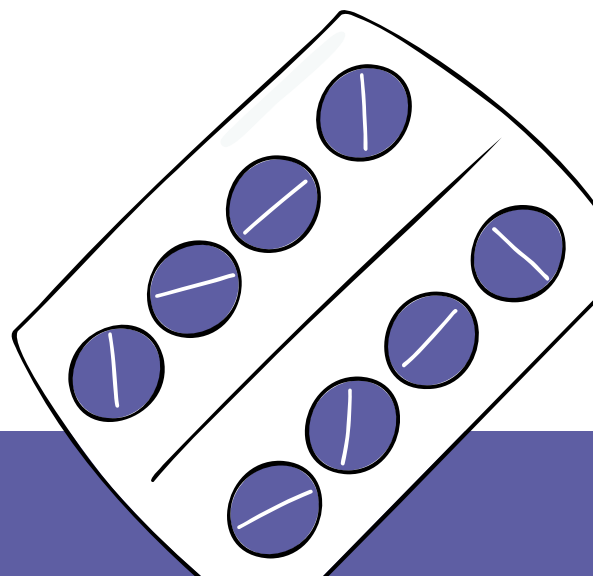
SELECCIÓN, PRESCRIPCIÓN, VALIDACIÓN, DISPENSACIÓN, ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO

CENTROS DE SALUD DONDE SE ADMINISTTRAN LOS FARMACOS

LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS SE REALIZAN EN DISTINTOS CENTROS DE SALUD, INCLUYEN EN CESFAMS, HOSPITALES Y CONSULTORIOS.

- **EN CONSULTORIOS Y CESFAMS:** OFRECEN LA ATENCIÓN PRIMARIA, INCLUYENDO LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES COMUNES.
- **HOSPITALES:** TAMBIÉN ADMINISTTRAN MEDICAMENTOS, ESPECIALMENTE EN CASOS DE MAYOR COMPLEJIDAD O PARA PACIENTES INTERNADOS.
- **POSTAS DE SALUD RURALES:** PROPORCIONAN ATENCIÓN PRIMARIA EN AREAS RURALES Y PUEDEN ADMINISTRAR MEDICAMENTOS
- **SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD:** ATIENDE URGENCIAS DE MAYOR Y MEDIANA COMPLEJIDAD
- **COSAM :**ATIENDE LA SALUD MENTAL Y PUEDEN ADMINISTRAR MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO

EN RESUMEN, LOS MEDICAMENTOS SE ADMINISTTRAN EN UNA VARIEDAD DE CENTROS DE SALUD, DEPENDIENDO DEL TIPO DE ATENCION Y LA CONDICION DEL PACIENTE



COMO AFECTA A LA POBLACION

SALUD DEL PACIENTE

- PUEDE CAUSAR REACCIONES ADVERSAS GRAVES, HOSPITALIZACIONES PROLONGADAS O INCLUSO MUERTES
- RIESGO MAYOR PARA ADULTOS MAYORES, NIÑOS Y PACIENTES CRÓNICOS.

SISTEMA DE SALUD

- AUMENTO EN LOS COSTOS POR TRATAMIENTOS ADICIONALES, JUICIOS POR MALA PRAXIS Y PÉRDIDA DE INSUMOS.
- SOBRECARGA DEL PERSONAL MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, GENERANDO MÁS ERRORES EN UN CICLO REPETITIVO.

CONFIANZA

- CASOS DE NEGLIGENCIA GENERAN MIEDO EN LA POBLACIÓN AL MOMENTO DE ACCEDER A TRATAMIENTOS.
- DISMINUYE LA CREDIBILIDAD DE HOSPITALES PÚBLICOS.

SALUD MENTAL Y EMOCIONAL

- AFECTA TANTO A LOS PACIENTES COMO AL PERSONAL DE SALUD IMPLICADO.
- FAMILIAS QUE PIERDEN A UN SER QUERIDO POR UN ERROR EVITABLE ENFRENTAN GRAVES CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS.





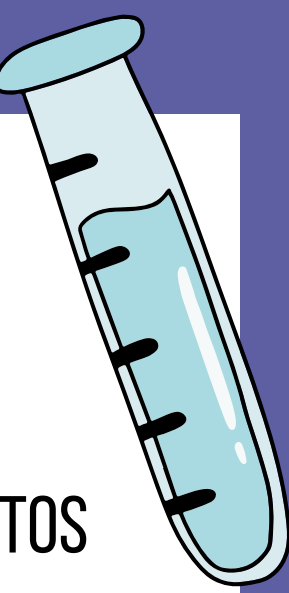
CIFRAS

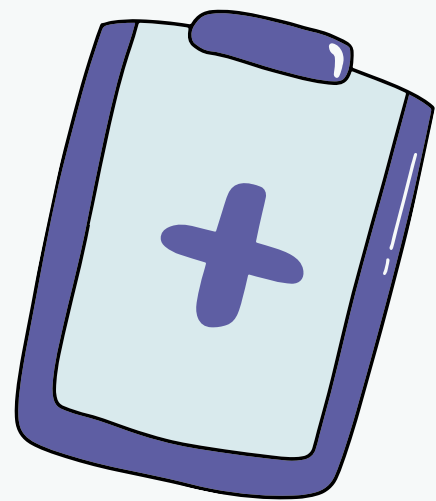
29 DE ENERO PASADO, LA SEREMI DE SALUD VISITÓ EL HOSPITAL EL CARMEN DE MAIPÚ Y DETECTÓ UNA SERIE DE INFRACCIONES.

CIPER ACCEDIÓ A UN DOCUMENTO QUE CONTIENE EL DETALLE DE ESOS HALLAZGOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN QUE 112 INSUMOS Y MEDICAMENTOS UBICADOS EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS ESTABAN VENCIDOS, Y QUE OCHO DE ESOS PRODUCTOS MANTENÍAN UNA ALERTA DE RETIRO EMITIDA DESDE OCTUBRE DE 2024 POR EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA (ISP)

EN JULIO DE 2024, LA CONTRALORÍA REALIZÓ UN SEGUIMIENTO AL HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DÍAS DE DIEGO DE ALMAGRO. PORQUE CASI UN AÑO ANTES, EL ORGANISMO HABÍA DETECTADO 33.758 UNIDADES DE FÁRMACOS CADUCADOS

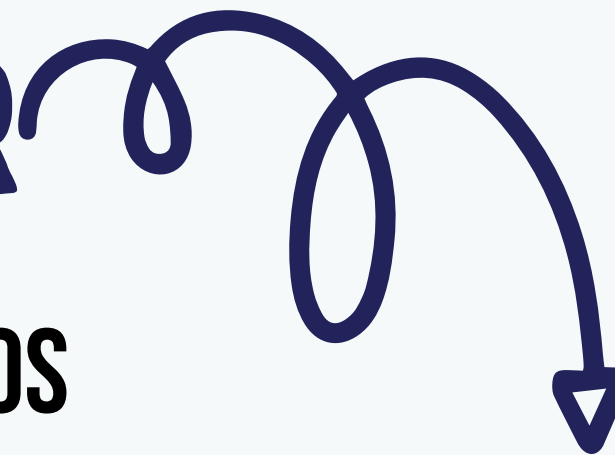
ESTRATEGIAS

- CAPACITANDO AL PERSONAL EN MANEJO DE MEDICAMENTOS:
 - SIMULACIONES PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN SEGURA
 - ACTUALIZACIÓN DE FÁRMACOS DE ALTO RIESGO
 - EVALUACIONES PERIÓDICAS Y PROTOCOLOS
 - CREAR UN SISTEMA PARA TODOS LOS HOSPITALES/CLINICAS:
 - ANÁLISIS DE ERRORES Y CAUSAS DE RAÍZ
 - PLAN DE MEJORA EN ERRORES
 - ANÁLISIS VIRTUAL
 - PLATAFORMA DIGITAL
 - ETIQUETADO:
 - ETIQUETADO DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO
 - ETIQUETADO PARA MEDICAMENTOS PRONTO POR VENCER
- 



OBJETIVOS AL ADMINISTRAR MEDICAMENTOS ✨ ✨

OBJETIVOS

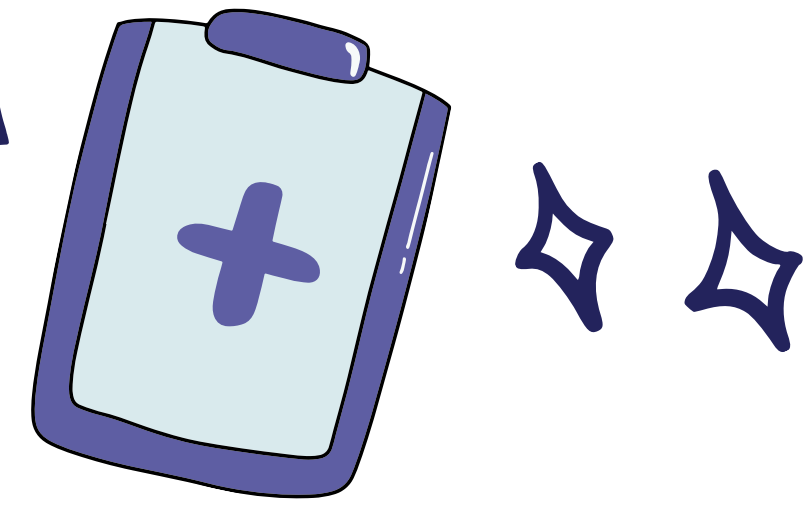


TIPO DE PACIENTE AL QUE VA DIRIGIDO:

- 1- PACIENTES HOSPITALIZADOS, ESPECIALMENTE EN UNIDADES CRÍTICAS COMO UCI, URGENCIAS Y MEDICINA INTERNA.
- 2 - ADULTOS MAYORES, QUIENES SON MÁS VULNERABLES A ERRORES DEBIDO A LA POLIFARMACIA Y COMORBILIDADES.
- 3- PACIENTES PEDIÁTRICOS, DEBIDO A LA NECESIDAD DE CÁLCULOS PRECISOS EN LAS DOSIS SEGÚN PESO Y EDAD.
- 4- PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS QUE REQUIEREN MÚLTIPLES MEDICAMENTOS Y SEGUIMIENTO CONTINUO.

1. PREVENIR ERRORES DE MEDICACIÓN EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO: PRESCRIPCIÓN, TRANSCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN, PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
2. DETECTAR Y REPORTAR LOS ERRORES DE FORMA OPORTUNA PARA EVITAR QUE LLEGUEN AL PACIENTE O GENEREN DAÑO.
3. ESTABLECER MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA, PROMOViendo UNA CULTURA DE SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN DE SALUD.
4. CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD SOBRE PRÁCTICAS SEGURAS DE MEDICACIÓN Y USO DE SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN.
5. PROTEGER AL PACIENTE REDUCIENDO LOS EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS.

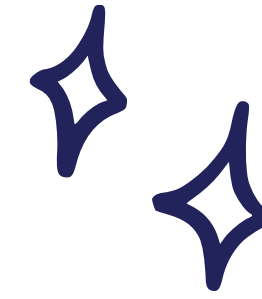
RESPONSABILIDADES DE LA BUENA O MALA ADMINISTRACION



- MÉDICO TRATANTE O MÉDICO DE TURNO: PRESCRIPCIÓN, PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (EN EL CASO DE ANESTESISTAS), REGISTRO EN FICHA CLÍNICA Y ELABORACIÓN DE RECETAS.
- MATRONA: INDICACIÓN Y REGISTRO DE MEDICAMENTOS, TRANSCRIPCIÓN DE INDICACIONES, PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.
- ENFERMERA(O): TRANSCRIPCIÓN DE INDICACIONES, REVISIÓN DE TARJETERO, PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.

- QUÍMICO FARMACÉUTICO: PREPARACIÓN, ETIQUETACIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS.
- TECNÓLOGO MÉDICO: ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN ALGUNOS CASOS, SEGÚN SU ÁREA DE TRABAJO.
- TÉCNICO PARAMÉDICO: DISPENSACIÓN, PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS BAJO SUPERVISIÓN DE UN PROFESIONAL DELEGADO.

LO QUE DEBEMOS SABER A LA HORA DE ADMINISTRAR UN MEDICAMENTO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE



USAR LOS CINCO CORRECTO:

- **PACIENTE CORRECTO:** VERIFICAR LA IDENTIDAD DEL PACIENTE ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN.
- **MEDICAMENTO CORRECTO:** CONFIRMAR QUE SE ESTA ADMINISTRACIÓN EL MEDICAMENTO CORRECTO SEGUN LA PRESCRIPCIÓN.
- **DOSIS CORRECTA:** ASEGURARSE DE QUE SE ESTA ADMINISTRANDO LA DOSIS CORRECTA, SEGÚN LA PRESCRIPCIÓN Y LA FORMA DE PRESENTACION DEL MEDICAMENTO.
- **VIA CORRECTA:** ASEGURA DE QUE SE ESTA ADMINISTRANDO EL MEDICAMENTO POR LA VIA CORRECTA, SEGUN LA PRESCRIPCIÓN.
- **MOMENTO CORRECTO:** ADMINISTRAR EL MEDICAMENTO A LA HORA CORRECTA, SEGUN LA PRESCRIPCIÓN

LO QUE DEBEMOS SABER ANTES DE ADMINISTRAR MEDICAMENTO:

- YO PREPARO
- YO ADMINISTRO
- YO REGISTRO
- YO RESPONDO



✧ ✧ **GRACIAS** ✧ ✧

Por su atención